

ÉTUDE POLYGRAPHIQUE DU SOMMEIL

Rapport d'Analyse Respiratoire et Oxymétrie

Dr. Selma BAKHA

Pneumologue - Allergologue

N° Ordre : 0535/24

☎ 0663 755 584

📍 Cité 19 Juin, derrière l'hôpital Hakim Okbi
en face des urgences, Guelma

✉ selma.bakha@hotmail.com

INFORMATIONS DU PATIENT

Nom :	MEGHAR	ID Patient :	20260924-138
Genre :	Féminin	Période enreg. :	00 :25 – 08 :01
Âge :	74 ans (née le 15/12/1951)	Durée totale :	456,0 min (7h 36min)
Taille / Poids :	144 cm / 80 kg	Durée valide :	456,0 min (100,0 %)
IMC :	38,6 kg/m ² (Obésité Grade II)	Date d'examen :	24 Septembre 2026
Contexte :	Bilan d'un syndrome d'apnées-hypopnées obstructives du sommeil		



Scanner pour accéder au tracé complet et dossier numérique

1. GRAPHIQUE DE TENDANCE POLYGRAPHIQUE

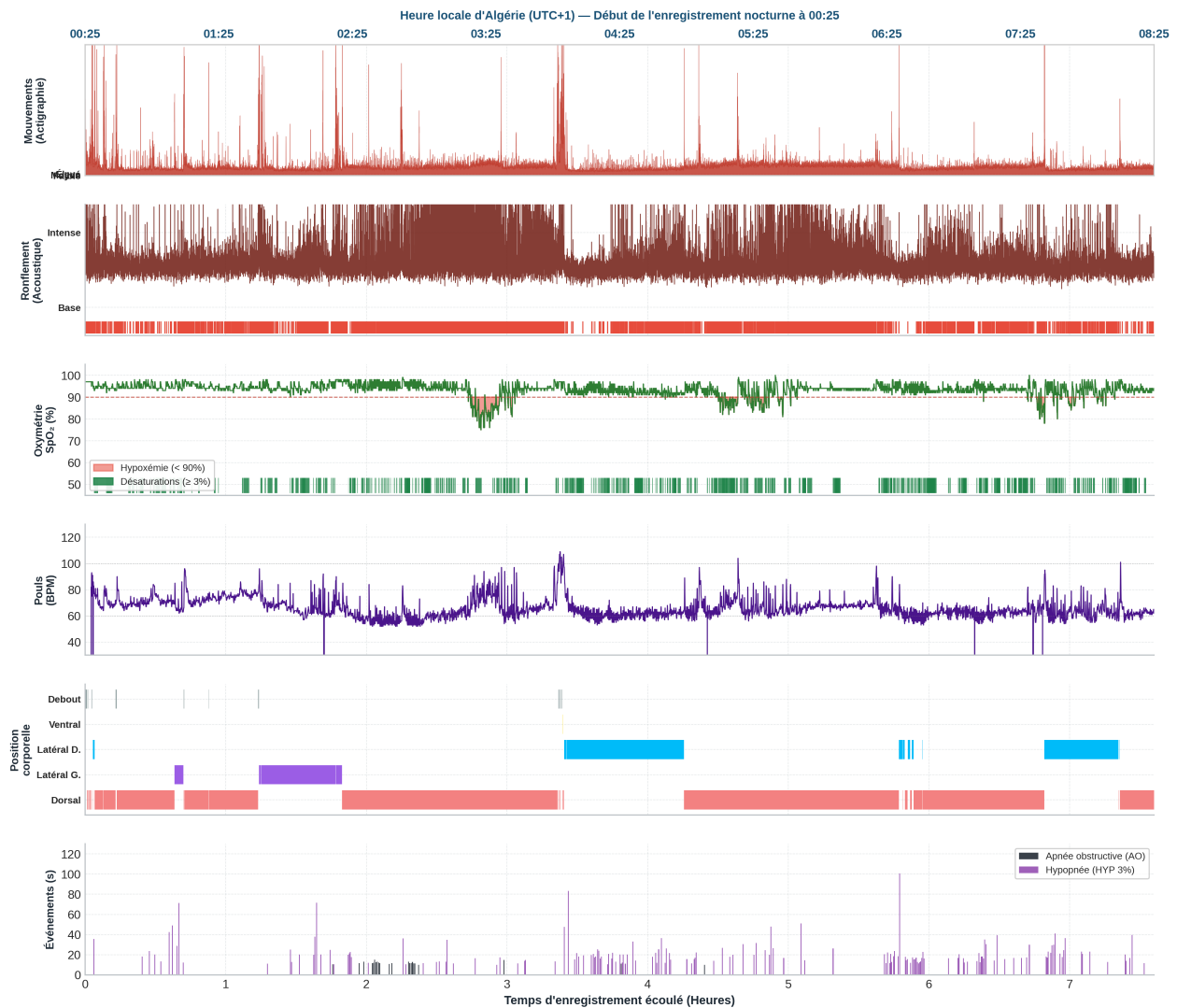


FIGURE 1 – **Enregistrement continu multicanal (00 :25–08 :01)** : Variations oxymétriques (SpO₂), débit nasal par lunette, fréquence du pouls, position corporelle et identification des événements respiratoires hypopnéiques prédominant en décubitus dorsal.

2. ANALYSE DES ÉVÉNEMENTS DU SOMMEIL

2.1. DISTRIBUTION POSTURALE ET IMPACT VENTILATOIRE

TABLE 1 – Événements respiratoires et désaturations selon la position

Position	Durée (min)	%	HYPO	SAOS	AC	AM	DO	IDO (/h)	Total Resp.
Dorsale (SUP)	324,3	71,1 %	159	56	8	5	247	45,7	228
Ventrale (PRO)	0,2	0,1 %	0	0	0	0	0	—	0
Côté gauche (LAT-G)	39,1	8,6 %	10	0	0	0	24	36,8	10
Côté droit (LAT-D)	88,4	19,4 %	51	30	0	0	105	71,3	81
Érigée (STAND)	3,9	0,9 %	1	0	0	0	3	46,2	1
Total / Moyenne	456,0	100 %	221	86	8	5	379	49,9¹	320

2.2. CINÉTIQUE DE L'OXYMÉTRIE DE POULS (SpO₂)

TABLE 2 – Paramètres oxymétriques détaillés

Paramètre Oxymétrique	Valeur	Norme
SpO ₂ maximale (%)	99	
SpO ₂ minimale (Nadir oxymétrique critique)	75	
SpO ₂ moyenne (%)	93	
Durée cumulée des désaturations relatives (min)	232,0	50,9 % du
Durée moyenne d'une désaturation	36,7 s	
Durée maximale d'une désaturation	120,0 s	
Nombre total d'événements de désaturation (DO)	379	
Index de Désaturation en Oxygène (IDO global)	49,9 /h	
Index de Désaturation en Décubitus Dorsal	45,7 /h	
Index de Désaturation en Latéral Droit	71,3 /h	
Temps passé sous 95 % de SpO ₂ (min)	318,2	70,3 % d
Temps sous 90 % de SpO ₂ (T90 en min)	38,1	8,4 % du
Temps passé sous 85 % de SpO ₂ (min)	11,8	2,6 % d
Temps passé sous 80 % de SpO ₂ (min)	1,8	0,4 % d
Charge Hypoxique (Hypoxic Burden, Azarbarzin)	120,78 %·min/h	Risque CV très élevé (> 2

2.3. ANALYSE DES ÉVÉNEMENTS RESPIRATOIRES

TABLE 3 – Caractérisation et indexation ventilatoire

Catégorie Événementielle	Nombre	Index (/h)
Apnées (Total : 99)		
Apnées Obstructives (SAOS)	86	
Apnées Centrales (AC)	8	
Apnées Mixtes (AM)	5	
Durée cumulée des apnées	22,0 min	(4,8 % du temps total)
Durée moyenne / Durée maximale	13,3 s	38,0 s
Hypopnées (Total : 221)		
Nombre total d'hypopnées	221	29,1
Durée cumulée des hypopnées	68,8 min	(15,1 % du temps total)
Durée moyenne / Durée maximale	18,7 s	84,9 s
Synthèse Ventilatoire Globale		
Nombre cumulé d'événements respiratoires	320	—
Durée totale cumulée sous événement	90,7 min	19,9 % de l'enregistrement
Durée moyenne d'un événement	17,0 s	—
Index d'Apnées-Hypopnées (IAH / REI)	—	42,1 /h
Index de Désaturation en Oxygène (IDO)	—	49,9 /h
Indice de Ronflement (Snoring Index)	—	2,0 /h

3. TABLEAU DE BORD SYNTHÉTIQUE

TABLE 4 – Récapitulatif des biomarqueurs polygraphiques

Indicateur	Valeur	Indicateur	Valeur
SpO ₂ moyenne (%)	93 %	SpO ₂ minimale (%)	75 %
IDO global (/h)	49,9	IDO latéral droit (/h)	71,3
Charge Hypoxique (%·min/h)	120,78	Temps sous 90 % (T90)	8,4 % (38,1 min)
Temps total d'enregistrement	456,0 min (7h 36)	Index Central (/h)	1,1
Index d'Apnées (IA /h)	13,0	Nombre d'Hypopnées	221 (IH : 29,1/h)
IAH / REI global (/h)	42,1	Changements de position	193²
Fréquence cardiaque moyenne	65,8 bpm	FC min / FC max (bpm)	52 / 109
IMC (kg/m ²)	38,6	Durée max Hypopnée (s)	84,9

2. Nombre de transitions positionnelles particulièrement élevé, suggérant une instabilité posturale ou une fragmentation du sommeil (éveils motriciels / artéfacts accélérométriques).

4. AVIS MÉDICAL ET CONDUITE À TENIR

1. Synthèse polygraphique

- **Sévérité majeure du trouble respiratoire** : l'enregistrement confirme un **Syndrome d'Apnées-Hypopnées Obstructives du Sommeil (SAHOS) sévère** avec un IAH (REI) à **42,1 /h** (320 événements, dont 221 hypopnées et 86 apnées obstructives).
- **Hypoxémie nocturne sévère** : nadir critique à **75 %**, T90 à **8,4 %** (38,1 min sous 90 % de SpO₂) et **charge hypoxique majeure à 120,78 %·min/h** (méthode Azarbarzin), attestant d'une contrainte hypoxique et d'un risque cardiovasculaire très élevés.
- **Profil positionnel** : nette aggravation de l'instabilité oxymétrique en décubitus latéral droit (IDO à 71,3 /h) et prépondérance des apnées en décubitus dorsal.

2. Conclusion diagnostique

- **SAHOS sévère** à nette prédominance obstructive.

3. Conduite à tenir proposée

1. **Pression Positive Continue (PPC) en mode autopiloté (APAP)** : indication formelle prioritaire de première intention avec rampe d'adaptation et interface adaptée (bucco-nasale).
2. **Bilan cardiologique de retentissement** : consultation cardiologique avec ECG et **Écho-cardiographie Doppler transthoracique (ETT)** à la recherche d'une hypertrophie ventriculaire gauche (HVG) et d'une hypertension pulmonaire (HTAP).
3. **Mesures hygiéno-diététiques associées** : prise en charge nutritionnelle ciblée et éviction formelle des substances dépressives du système nerveux central (sédatifs, myorelaxants).

Dr. Selma BAKHA

Pneumologue - Allergologue
Guelma, le 24 Septembre 2026